

klinische SOP (K40 Hernia inguinalis)

In medizinisch begründeten Fällen kann bzw. muss von der vereinbarten SOP abgewichen werden. Diese Abweichung ist jedenfalls zu dokumentieren.

Dieser Standard ist für PatientInnen ab dem 18. Lebensjahr gültig. Werden die strukturellen Voraussetzungen (FA für Kinderchirurgie) erfüllt, kann der Standard auch unter 18. Jahren angewendet werden. Ausnahme PatientInnen von 0 - 3 Jahren.

Differentialdiagnose

Hodenhochstand, Lymphknoten, Hydrocele, akuter Hodenschmerz (Torquierung, Entzündung), unklarer Leistenschmerz

Therapieziel

1.) Bruchlücken Verschluss.

Befunde

Standardbefund	☐ Körperliche Untersuchung
Zusatzuntersuchungen	☐ Ultraschall mit Valsalva Pressversuch wenn klinisch Unklarheit besteht. ☐ CT Abdomen oder MRI wenn Klinik und Ultraschall inkonklusiv sind
Labor	☐ Präoperativ: bei unauffälliger Anamnese kein Labor; Anwendung der BQLL präoperative Diagnostik durch die Anästhesie ☐ Postoperativ: Keines

Konservative Therapie (optional)

--

Operative Therapie (optional)

Indikation	gesicherte Leistenhernie
Stationär/Tagesklinisch	Aufklärung und OP Revers mit dem Patienten durchgegangen. Stationär geplanter Patient: 1.) Termin Planung entsprechend Haus 2.) Vorstellung Pre-Anästhesieambulanz Tagesklinisch geplanter Patient: Grundsätzlich gilt: 1.) ASA 1 oder 2, nur in Ausnahmen ASA 3

	2.) Keine geplante postop. Intensivmedizin 3.) Analgesie Kontrolle postoperativ 4.) Patient ist zu Hause von volljähriger Person versorgt. 5.) Patient darf nicht selbst Auto fahren 24 Stunden 6.) Es dürfen keine Kontraindikationen gegen einen tagesklinischen Eingriff bestehen.
Operationsverfahren	Offen: mit oder ohne Netzaugmentation; laparoskopisch: TAPP, TEP
Nahtentfernung	5.-10 Tag postoperativ im niedergelassenen Bereich, bzw resorbierbares Nahtmaterial
Standardröntgen	Keines
TKL derzeit nicht empfohlen bei:	TAPP/TEP

Vorgehen bei akuten Komplikationen

--

Klinische Kontrollen

Stationär: am 1. postoperativen Tag im Rahmen der Visite beziehungsweise vor der Entlassung.

Tagesklinisch: bis 4 Stunden postoperativ Wundinspektion Entlassung durch den Operateur bzw autorisierter Vertretung.

Risiken

--

Dokumentation (optional)

Bei Vorgehen nach dieser SOP ist keine zusätzliche Dokumentation notwendig.

Optionale Überschriften nach Bedarf

--

Literatur, Links, Anlagen

Link: Fachgesellschaften Hernie

ÖGARI Richtlinien zur präoperativen Patientenevaluierung

Anlage: Tagesklinik Kontraindikationen